

14 - 01-SEMILOGIE DES INFECTIONS OSTEOARTICULAIRES ET DES PARTIES MOLLES (Teams) - Pr. AGHOUTANE

(0:00 - 1:04)

Ça veut dire que le germe passe par voie sanguine, donc il y a une phase de septicémie où le microbe ou le germe, les deux le sentent et par le sent, il va aller se localiser au niveau de la métaphyse d'un os, le plus souvent un os long. Donc, l'ostéomyélite, la contamination de l'os se fait toujours par voie hématogène, ce n'est pas par voie directe, par inoculation directe, non, c'est une inoculation par voie, par voie hématogène. C'est-à-dire qu'au niveau de la métaphyse d'un os, il y a une phase de septicémie où le microbe ou le germe passe par voie directe, par voie hématogène.

(1:30 - 2:11)

Donc, je répète ici que l'ostéomyélite ou la désinfection post-articulaire, leur diapositive par diapositive, c'est-à-dire qu'il y a une phase de septicémie où le microbe ou le germe passe par voie directe. Donc, il y a une phase de septicémie où le microbe ou le germe passe par voie directe. La question.

(2:19 - 2:42)

Ici, j'ai mis un schéma pour vous expliquer pourquoi le germe se localise au niveau de la métaphyse et pas la diaphyse. C'est pas le cartilage de croissance, c'est pas au niveau des épiphyses. Pourquoi j'ai choisi la métaphyse des os longs? Parce que la métaphyse est largement vascularisée.

(2:42 - 3:02)

Il y a beaucoup de sang qui arrive au niveau de la métaphyse de l'os, ce qui veut dire que le germe est au niveau du sang. Donc, quand il y a une quantité importante de sang qui arrive au niveau des régions, ça veut dire qu'il y a une quantité importante de germes. Ça, c'est la première raison.

(3:03 - 3:18)

C'est la métaphyse qui est largement vascularisée. Deuxième raison, parce qu'au niveau de la métaphyse, il y a un ralentissement circulatoire. Des larges sinusoïdes qui permettent un ralentissement circulatoire.

(3:18 - 3:35)

Il y a une quantité importante de germes qui arrive au niveau de la métaphyse. Et en plus, quand ce sang arrive au niveau de la métaphyse, il y a un ralentissement. Le germe va trouver le temps

nécessaire pour se fixer au niveau de la métaphyse.

(3:37 - 4:00)

Donc, il réalise ce qu'on appelle ici une thromboflipide septique. Thromboflipide septique, ça veut dire une réaction inflammatoire locale. Une réaction inflammatoire locale avec une écrose microscopique de l'œdème à l'intérieur de l'os.

(4:01 - 4:13)

Ce qui va entraîner quoi? À l'intérieur de l'os, quand il y a une éperpression, il y a de l'œdème. L'éperpression, ça entraîne ce qu'on va voir par la suite, la douleur. La douleur intense.

(4:13 - 4:41)

Parce que l'os, c'est un tissu compact, quand il y a de l'œdème à l'intérieur de l'os, ça entraîne l'éperpression très importante qui va entraîner la douleur. Et par la suite, si on ne traite pas, cette thromboflipide septique va augmenter de volume. Elle va augmenter de volume.

(4:42 - 4:52)

Elle va entraîner ce qu'on appelle, on va voir après, l'absence supérieure. C'est-à-dire la collection du but. Un but qui va remplir cette corticale-là et qui va entraîner une collection.

(4:52 - 5:26)

Mais au stade de début, l'os est aiguë, hématogène, donc il n'y a pas de rupture de la corticale. Donc, il y a une thromboflipide septique avec de l'œdème, l'appui du macrophage, une réaction inflammatoire très importante, avec comme conséquence une éperpression intraosseuse qui va expliquer par la suite la simbiologie clinique. Est-ce que c'est nouveau? Oui.

(5:28 - 5:56)

Comment, donc, est-ce que ça veut dire une diagnose injuste fait uniquement? Eh bien, les données cliniques. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des bilans. On va voir par la suite sur la simbiologie clinique, la simbiologie clinique sur l'examen clinique, on est capable de faire le diagnostic et de commencer le traitement parce qu'on va voir par la suite que le traitement est urgent.

(5:58 - 6:17)

S'il y a un retard d'une heure à douze heures, ça va entraîner des conséquences qu'on va voir par la suite. Des conséquences sur l'évolution de cette maladie grave. Donc, quand je dis qu'il est basé sur la simbiologie clinique, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire une prise de sang, je n'ai pas besoin de faire des radios pour faire le diagnostic.

(6:22 - 6:41)

Donc, la clinique, on a vu la prise de patte, sur le plan clinique, ça va entraîner quoi? Cette éperpression dans l'os, ça entraîne un tableau bruyant. Donc, le début, il est brutal. Chez un enfant, jusqu'ici, en pleine santé, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.

(6:42 - 6:49)

Il fait beau, et brutalement, il y a un coup de tonnerre. C'est comme ça. Donc, le début, il est brutal.

(6:49 - 6:56)

Ça s'installe de façon brutale. L'os est humide, ça s'installe de façon brutale. Il ne s'installe pas de façon progressive.

(6:57 - 7:22)

Donc, cette éperpression à l'intérieur de l'os va entraîner la douleur. C'est une douleur qui est très intense, qui est atroce, comme une véritable douleur de fracture au voisinage de l'articulation du genou. Ici, j'ai choisi le type de description, l'os est humide de l'extrémité inférieure de figure, parce que c'est la localisation la plus fréquente.

(7:23 - 7:42)

Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce type comme type de description. Mais l'os est humide peut toucher toutes les métaphyses osseuses. Il peut toucher l'hémérus, il peut toucher le radius, mais par ordre de fréquence, on a dit qu'il touche les cartilages fertiles, les métaphyses fertiles proches d'un cartilage fertile.

(7:42 - 8:06)

Et la localisation au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, au niveau de la métaphyse, reste la localisation la plus fréquente. Donc, on a dit que la douleur est intense, véritable douleur de fracture au voisinage de l'articulation du genou, qui va entraîner rapidement une impotence fonctionnelle totale. Ça veut dire que l'enfant n'arrive plus à bouger.

(8:06 - 8:21)

Donc, il a très mal. Il se réveille la nuit ou le matin de façon brutale, commence à avoir mal avec une douleur très atroce. Et bien sûr, le germe passe par voie sanguine.

(8:21 - 8:30)

On a dit que la contamination de la métaphyse se fait par voie sanguine. Ça veut dire que le

germe est de leçon. C'est comme les septicémies.

(8:30 - 8:51)

Donc, il y a des signes généraux. Il y a un syndrome infectieux, coïncident avec la douleur, avec fièvre, second supérieur à 39, des frissons, avec altération de l'état général. Quand je dis frissons, quand un malade frissonne, ça correspond à la décharge bactérienne.

(8:51 - 9:02)

Il y a une décharge des bactéries dans le sang, ça entraîne la frisson. Les frissons à l'arbre, c'est un groupe de frissons. C'est un groupe de frissons.

(9:04 - 9:43)

Donc, j'ai mis à l'interrogatoire, quand je demande à la maman qui ramène l'enfant à l'interrogatoire, on note la présence d'une notion de traumatisme dans un tiers des cas. Et cette notion de traumatisme, malheureusement, qui n'a pas de lien avec l'ostéomyélite, peut forcer le diagnostic. Ça veut dire un enfant qui vient comme ça, avec une douleur intense, et si le médecin ne prend pas la température, il peut rattacher cette douleur à un traumatisme.

(9:43 - 10:17)

Quand la maman dit que son enfant est tombé hier, et brutalement qu'il a commencé à avoir mal ce soir à 1h du matin, si je n'examine pas bien l'enfant, si je ne prends pas la température, je peux être induit en erreur avec des conséquences graves. Parce que si je traite ce tableau clinique en traumatisme, donc ça va évoluer vers des complications à 100%. J'ai mis qu'il n'y a pas de fracture en traumatisme avec hier.

(10:17 - 10:35)

Ça, c'est une règle générale. Quel que soit le traumatisme, quel que soit le type de fracture, il ne s'accompagne jamais de hier. Donc, chaque fois qu'on a une douleur osseuse avec hier, même s'il y a cette notion de traumatisme, ce n'est pas un traumatisme qui entraîne ce tableau clinique.

(10:35 - 11:02)

Un traumatisme, même avec une fracture très déplacée, ça n'entraîne pas une hier. Donc, il faut toujours examiner l'enfant et chercher cette fièvre. Parce que malheureusement, on continue à avoir des enfants qui n'ont pas été diagnostiqués à temps par des médecins parce que le médecin a rattaché la douleur au traumatisme.

(11:04 - 11:42)

Il n'a pas pris la température, il n'a pas bien examiné l'enfant et il l'a traité qu'en traumatisme.

Alors, comment on cherche? Avant de chercher la porte d'entrée, d'abord, qu'est-ce qu'on trouve à l'examen clinique? Donc, l'examen, pourquoi j'ai mis l'enfant? Parce que souvent, l'osseux humide, il touche l'enfant. Les infections osseux articulaires sont la panache.

(11:44 - 11:57)

Donc, 90% des cas, la plupart du temps, sont des enfants moins de 15 ans. J'ai mis que l'examen doit être doux et progressif. Donc, quand on veut examiner un enfant, c'est pas comme l'adulte.

(11:58 - 12:12)

Un enfant, il a peur, donc il a besoin que sa maman reste à côté de lui. Il ne va pas faire sortir toute sa famille et le laisser tout seul dans la salle d'examen comme l'adulte. Donc, il faut laisser quelqu'un avec lui pour le mettre en confiance.

(12:13 - 12:32)

Donc, on examine un enfant en présence de l'un des parents, dans une salle chauffée, parce qu'on va le déshabiller. Toujours il faut déshabiller le patient en examen osseux articulaire. S'il a mal au niveau du genou, je ne vais pas lui demander d'enlever seulement son pantalon.

(12:33 - 12:56)

Il faut enlever tout pour faire un examen général parce qu'on va voir par la suite que parfois il y a d'autres localisations. Il faut toujours examiner l'enfant, le déshabiller complètement dans une atmosphère chaude, en présence de l'un des parents pour le mettre en confiance. Sinon, vous saurez la situation d'un enfant qui pleure tout le temps.

(12:56 - 13:19)

Il ne va pas vous laisser examiner, faire l'examen clinique. Il faut toujours, pour l'enfant, le mettre en confiance en présence de l'un des parents. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'inspection? A l'inspection, moi j'ai pris ici l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure, de la fémur, de la métaphyse fémorale inférieure.

(13:19 - 13:37)

Donc, à l'inspection, il n'y a pas de rougeur, ni de stigmatisation. Donc, l'inspection est normale. Donc, à l'ostéomyélite débutante, ça veut dire sans complication, à l'inspection, on constate qu'il n'y a rien.

(13:37 - 14:11)

Il n'y a ni rougeur, ni tumefaction, ni circulation veineuse collatérale. Mais à la palpation, qui doit

être une ubi-digitale, avec le doigt de la métaphyse inférieure, ça entraîne une douleur qui est intense, qui est circulaire, segmentaire, ça veut dire, seule la métaphyse, pas la diaphyse, pas l'épiphyse, qui est extra-articulaire. Une chose importante, la mobilisation douce de l'articulation du genou, elle est possible et non douloureuse.

(14:12 - 14:36)

Parce que le problème, c'est au niveau de la métaphyse, l'articulation à côté, sa mobilisation, elle est normale. Alors, on a dit, après cet examen clinique, on va trouver de la fièvre à 39, avec une douleur métaphysaire circulaire, segmentaire, extra-articulaire. Il faut rechercher les portes d'entrée.

(14:37 - 14:58)

On a dit que le germe est passé par la voie sanguine pour se localiser au niveau de la métaphyse. Donc, on doit chercher d'où le germe est entré. Donc, la porte d'entrée, c'est là que le germe a pris comme inoculation.

(14:59 - 15:07)

Ça peut être une plaie. Généralement, la porte d'entrée, elle est loin de la métaphyse. Ce n'est pas un regard.

(15:08 - 15:28)

C'est loin. Généralement, un foyer ORL, on va demander au patient ce qu'il a fait ces derniers jours. Une pharyngite, est-ce qu'il a fait une otite qui n'a pas été bien traitée ? Généralement, cette porte d'entrée, elle date de quelques jours avant l'installation du tableau clinique de l'hospital Milit.

(15:29 - 15:51)

Donc, la porte d'entrée, on la cherche en demandant à la famille ce qu'il a fait il y a une semaine, il y a 10 jours, une pharyngite qu'il n'a pas traitée. Est-ce qu'il a fait une otite ? On va chercher cliniquement à l'inspection. Est-ce qu'il y a une plaie cervicale ? Il y a une petite plaie au niveau du cervical, au niveau du visage.

(15:51 - 16:03)

Donc, des stigmates d'une infection qui remonte à quelques jours que l'enfant n'a pas traitée. Mais on a dit que la présence de cette porte d'entrée n'est pas constante. Parfois, on ne trouve rien.

(16:05 - 16:20)

Vous allez me dire comment le gène est entré. Il est entré par une petite... Il n'a pas lavé les mains. Donc, il a mis la main sur quelque chose microscopique qu'on ne va pas trouver.

(16:20 - 16:45)

Donc, cette porte d'entrée parlante comme ça n'est pas toujours présente. La question, pourquoi il n'y a pas d'une infection ? Alors, pourquoi on a l'œdème intraosseux ? Mais c'est à l'intérieur de l'os, l'œdème. On ne va pas voir l'œdème.

L'os, c'est solide. L'os, c'est comme un morceau de bois. S'il y a de l'œdème à l'intérieur d'un morceau de bois, s'il n'y a plus de chose, à l'extérieur, il n'y a rien.

(16:45 - 17:01)

C'est à l'intérieur de l'os. D'accord ? L'œdème, ça ne va pas déformer l'os. Oui ? S'il vous plaît, est-ce qu'il est avantageux de faire une imagerie ou essayer de bien diagnostiquer ? Non, c'est la simbiologie clinique.

(17:02 - 17:14)

Jusqu'à maintenant, on est dans la simbiologie clinique. Cette pathologie, si on part d'une heure, le pronostic va changer. C'est parmi les pathologies les plus urgentes à commencer le traitement antibiotique.

(17:15 - 17:28)

C'est l'ostéomyélie. On va voir après si on ne traite pas. Dans les 15-30 minutes, ça va évoluer vers des complications qui vont avoir un retentissement sur la croissance de l'os de l'enfant.

(17:29 - 17:51)

Là, on est devant des enfants en pleine croissance. Dans une zone qui est proche du cartilage de croissance, toute atteinte, toute complication, ça va retentir sur la croissance de l'enfant et parfois même sur le pronostic vital de l'enfant. Donc, on n'a pas le droit de demander quelque chose et attendre.

(17:51 - 18:15)

On va voir après que le bilan, on peut le demander une fois qu'on a commencé le traitement. Si j'amuse à demander à une radiographie d'attendre une heure, pour qu'elle fasse la radiographie, qui ne va m'apporter rien du tout. Donc, je vais traiter avec retard, avec des complications à coup sûr.

(18:16 - 18:24)

Ça signifie la douleur segmentaire. C'est une douleur au niveau de la métaphyse. Le segment osseux, c'est la métaphyse.

(18:25 - 18:35)

Donc, on va palper comme une bande circulaire où il a mal, au-dessous, il n'a pas mal. C'est votre segment métaphysaire qui est circulaire. Donc, je mets le doigt.

(18:35 - 18:47)

C'est pourquoi j'ai mis une palpation digitale avec le doigt, pas avec la paume de la main. Donc, j'ai une palpation sur la zone métaphysaire qui est très étroite, la zone métaphysaire. C'est comme une bande de 1 cm.

(18:47 - 18:53)

Donc, je palpe la diaphyse, il n'a pas mal. Je descends un petit peu. À un certain moment, il a très, très mal.

(18:53 - 18:58)

C'est la métaphyse. Si je descends un petit peu en bas, il n'a pas mal. En haut, il n'a pas mal.

(18:58 - 19:14)

Donc, c'est le segment de la métaphyse. Donc, une fois que j'ai fait cet examen clinique, devant cette douleur osseuse d'installation brutale, avec fièvre, j'ai une osseïe ombilique et une gynématurgie. Point.

(19:14 - 19:34)

Donc, on n'a pas le droit de retarder le traitement. Après avoir commencé le traitement, on peut demander du bilan. D'accord? Donc, la présence d'une douleur pareille dans un contexte fébrile doit faire évoquer l'ostéomyélite aiguë jusqu'à preuve de contraire.

(19:37 - 19:55)

Donc, Laurence, c'est un chirurgien ancien, les années 60, qui a dit ça il y a plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? L'antibiotique dans un quart d'heure et le plâtre dans 12 heures. C'est Laurence qui l'a dit il y a plus de 60 ans.

(19:55 - 20:11)

Donc, une fois que j'ai ce tableau clinique, il faut commencer l'antibiotique dans 15 minutes. On n'a pas le droit de retarder. Ce qu'on fait sur le plan pratique, on fait juste un prélèvement sanguin

pour avoir les marques de l'inflammation.

(20:11 - 20:21)

On injecte la première dose d'antibiotique. Donc, il a dit plâtre dans 12 heures, ça c'était il y a 60 ans. Cette notion de plâtre, elle est à revoir.

(20:21 - 20:41)

Donc, on ne va pas entrer dans le chapitre du traitement. Mais juste pour vous dire que sur l'ostémiologie clinique, on peut faire le diagnostic et commencer le traitement. Je ne commence pas, je n'attends pas le bilan, faire NFS, CRP, attendre une heure, retarder le diagnostic.

(20:41 - 21:01)

Donc, commencer l'antibiotique et après on peut récupérer le bilan et voir l'inflammation. Est-ce que vous avez des questions ici? Donc, c'est une urgence thérapeutique. Donc, une douleur osseuse plus fièvre égale à l'ostéomyélite aiguillematogène jusqu'à preuve de contraire.

(21:10 - 21:35)

Les formes cliniques, ici on a parlé de l'ostéomyélite aiguillematogène, de l'extrémité inférieure de fumeur, qui est la forme la plus fréquente. Mais, il y a des formes cliniques, toujours en médecine, il y a la forme typique, la plus fréquente. Mais il y a d'autres formes cliniques, comme ici la forme, la septico-pioïmie.

(21:35 - 22:07)

C'est quoi la septico-pioïmie? C'est une atteinte multifocale par un staphylococcus aureus virulent, qui va entraîner une atteinte multifocale. Ça veut dire qu'il va toucher plusieurs métaphyses à la fois et il va toucher même des organes comme le poumon, le cœur et les méninges. Généralement, c'est un staphylococcus virulent qu'on appelle le staphylococcus sécrèteur de la toxine de ponton et valentine.

(22:07 - 22:34)

Donc c'est un germe, un staphylococcus qui est un peu virulent, donc c'est une souche qui est virulente, sécrétant de la toxine de ponton et valentine qui va entraîner cette forme clinique grave. Donc dès le début, ce qu'on a, on a un tableau septique grave associant l'ostéomyélite à une atteinte multiviscérale avec un risque vital très important. Il y a l'atteinte pulmonaire avec un staphylococcus pleuropulmonaire.

(22:34 - 22:52)

Donc c'est l'enfant qui vient avec la douleur osseuse, la fièvre et en plus, il a une dysplique avec

une gêne respiratoire. Ça peut avoir une péricardie périllante associée avec une dysplique. À l'examen clinique, un assourdissement des bruits du cœur et un frottement péricardique.

(22:53 - 23:10)

Et on peut trouver une raideur méningique qui traduit l'atteinte neuroméningique avec un risque vital très important. Cette forme clinique, heureusement, elle est rare, mais elle existe. Donc la forme septico-pionique, c'est une atteinte multiviscérale associée à l'ostéomyélite.

(23:11 - 23:31)

Donc l'ostéomyélite, qui peut être une atteinte multiple de plusieurs métaphyses. Ça veut dire qu'on va trouver une douleur métaphysaire fémorale inférieure, tibiale supérieure du côté contralatéral, par exemple, avec une dysplique, un frottement péricardique, une raideur méningée. Donc c'est une forme clinique qui est grave.

(23:31 - 23:52)

C'est une forme septique de l'ostéomyélite aiguë et hématogène. Heureusement, cette forme, elle est rare. Est-ce que vous avez des questions sur ce diapositif? Ça, c'est la première forme clinique grave.

(24:00 - 24:25)

Là, on va passer aux formes cliniques évolutives. Ça veut dire l'ostéomyélite aiguë et hématogène, si on ne traite pas à temps, si je me demande un bilan j'attends et je commence le traitement avec retard, ça va évoluer vers l'abcès-supériorité. Donc l'abcès-supériorité, c'est une complication toujours d'une ostéomyélite aiguë et hématogène, non, pour maltraiter.

(24:26 - 26:06)

Non-traités sont des enfants qui partent, qui partent chez le shabab, le shabab c'est le guérisseur, pas guérisseur, c'est le charlatan traditionnel, et qui traitent ça comme traumatisme, parce qu'on a dit dans 30%, la maman rapporte cette notion de traumatisme et ce shabab, donc il va faire un bandage sur le membre atteint, il va le traiter comme traumatisme et il va évoluer à coup sûr vers l'abcès-supériorité. Le deuxième cas de figure, ce sont des ostéomyélites maltraitées, soit en retard de prise en charge, on donne un bilan et on attend un petit peu, trois heures, quatre heures, et ça va évoluer vers l'abcès-supériorité, ou on ne traite pas correctement, on ne va pas parler aujourd'hui du traitement, soit on donne une dose d'antibiotiques non suffisante, soit on donne un antibiotique non adapté, donc tous ces éléments-là vont entraîner l'évolution vers l'abcès-supériorité. C'est quoi l'abcès-supériorité ? On a dit tout à l'heure, sur la flèche, ici, si l'ostéomyélite est hématogène, au stade de la flèche, il y a un tromboclibide cytique, si je ne traite pas rapidement, il y a une constitution de pus dans l'os, ce pus va augmenter de volume, à un certain moment, il va rompre la corticale, il va sortir de

l'intérieur de l'os, je reviens vers notre mademoiselle qui a posé la question sur la collection, la thymifaction.

(26:07 - 26:38)

Ici, il y aura une thymifaction, Parce que le pus est sorti de l'os, il a rompu la corticale, puis il a formé une collection périllante sous le périoste. Donc à l'extérieur de l'os, mais sous le périoste, parce que l'os, c'est-à-dire qu'il est enveloppé d'un périoste, une membrane osseuse épaisse. Donc le pus va sortir de l'intérieur de l'os, il y aura une suffaction.

(26:39 - 27:00)

Il va constituer une collection sous le périoste. La douleur ici devient moins importante parce qu'il n'y a plus d'éperpression entre osseuses. Ce pus qui est entraîné au début, il y a une éperpression très importante parce qu'il est à l'intérieur d'un espace compact.

(27:00 - 27:21)

Il va exploser, il va sortir de l'os, donc l'éperpression, bien sûr, ça va diminuer nettement et ça va entraîner une régression de la douleur, comme on va voir par la suite. Donc ici, l'abscisse supérieure, c'est sur le pus, à l'intérieur, à l'extérieur de l'os, sur le périoste. Ce pus, malheureusement, il contient de l'os nécrosé.

(27:23 - 27:45)

Il va interrompre la vascularisation corticale parce que l'os est vascularisé par des vaisseaux qui viennent par le périoste, comme ça, perpendiculaire. S'il y a de plus, ça va interrompre cette vascularisation et ça va entraîner la mort de l'os, ce qu'on appelle les séquestres osseux. Les séquestres osseux, c'est la partie de l'os morte.

(27:45 - 28:11)

Donc ces séquestres osseux vont entraîner la chronicité, la pérennisation de l'infection osseuse. Donc ici, on est passé à un autre stade où il y a une interruption de la vascularisation. Comment on peut connaître le stade de l'infection? Le stade de l'infection, c'est l'intérêt de la simbiologie clinique.

(28:11 - 28:28)

On va voir la simbiologie clinique par la suite. Sur l'examen clinique, on va voir le stade cliniquement. C'est un enfant qui arrive avec ses parents.

(28:29 - 28:57)

Déjà à l'interrogatoire, quand je demande au papa ou à la maman, ils vont rapporter que leur

enfant a fait une douleur osseuse brutale avec fièvre à 39 il y a deux jours. Ils n'ont pas ramené l'enfant parce qu'ils sont partis sur un médecin qui a pensé au traumatisme. Il les a traités par anti-inflammatoires, il n'a pas pris la température.

(28:58 - 29:21)

Et la maman revient parce qu'elle a constaté l'apparition d'une tumefaction osseuse. Dans ce stade, il y a la tumefaction osseuse. L'histoire clinique, ça remonte deux à trois jours après l'épisode d'ostéomyélite pour l'apparition d'une tumefaction osseuse chaude et douloureuse.

(29:22 - 29:41)

Dans ce cas, à l'inspection, au contraire de l'ostéomyélite, on va constater, si je prends l'ostéomyélite, la supériorité de l'extrémité inférieure du fémur. Donc à l'inspection, est-ce qu'il y aura une tumefaction ? Une rougeur et une tumefaction, oui. Parce que le puits, il est sorti de l'os.

(29:42 - 30:01)

Donc il y a une tumefaction, il y a une rougeur. À la palpation, est-ce qu'il y aura la douleur métaphysée ? Il y aura une petite douleur, pas comme avant, mais il y aura la douleur. La mobilisation de l'articulation, elle est normale parce que l'articulation est libre.

(30:02 - 30:20)

Ici en général, on a dit que l'hyperpression au stade de l'ostéomyélite va disparaître parce qu'il n'y a plus de puits à l'intérieur de l'os. Donc la douleur devient moins intense, il y a une douleur, mais moins intense. Donc la maman qui va vous dire, mon enfant a présenté il y a 2-3 jours une douleur intense.

(30:21 - 30:34)

Il a pris un traitement par un médecin, mais maintenant il y a l'apparition d'une tumefaction. La douleur a diminué, il arrive à dormir la nuit, heureusement. La fièvre était à 39, 39,5, maintenant il est à 38.

(30:34 - 31:02)

Donc le syndrome, ici en général, ils sont présents, mais ils sont moins sévères par rapport au stade d'ostéomyélite. Donc la douleur et la fièvre, ils ont diminué. Donc au stade d'abstinence supérieure, donc dans ce cas le virus, il est basé sur la sibiologie clinique, mais généralement on peut demander une échographie, on ne va pas détailler ça pour voir la collection du pus.

(31:02 - 31:31)

Bien sûr le traitement, en plus d'antibiotiques, il faut enlever le pus, c'est le drainage de pus qu'on appelle le drainage de pus, le drainage chirurgical. Et si le traitement devient chirurgical. À ce stade, si on traite correctement, on peut soit faire guérir l'enfant, soit même avec un traitement adapté, il peut passer, ce qu'on va voir par la suite, la chronicité, ce qu'on appelle l'ostéomyélite chronique.

(31:32 - 31:53)

Alors quel est l'aspect de la tuméfaction à la palpation de la zone de pus ? Alors la palpation de la tuméfaction, c'est une collection de pus, donc il est un peu molle, il est chaude. Ce n'est pas comme une collection du partie molle, ça ne bouge pas, ce n'est pas une collection très molle qui bouge. Donc il y a une collection chaude, douloureuse.

(31:53 - 32:10)

En regard de la métamorphose, en regard de l'os, ça c'est très important. Avec une fièvre à 38,5, la douleur devient moins importante, mais elle est là. Donc toute collection en regard de l'os, c'est un abcès supérieur jusqu'à 3,5.

(32:13 - 32:40)

Dans ce cas, le traitement devient chirurgical. Malheureusement, il y a un certain nombre de malades qui vont évoluer vers... Ici, c'est l'exemple d'un enfant de 7 ans qui est présenté avec l'ostéomyélite et l'igmatogène de la métamorphose tibiale supérieure. Ce n'est pas toujours la métamorphose fémurale inférieure.

(32:41 - 32:53)

On a pris la métamorphose fémurale inférieure comme type de description, mais ça peut toucher toutes les métamorphoses. Donc, non-traité qui revient après trois jours. Vous voyez très bien ici la tuméfaction.

(32:54 - 33:10)

Ça, c'est au bloc opératoire. Et quand on a fonctionné par insuline, vous voyez le but, ou le chocolat, donc chocolaté, donc le but, on regarde la métamorphose tibiale supérieure. Ça, c'est un abcès supérieur.

(33:11 - 33:30)

Ça, on le fait sous anesthésie générale au bloc opératoire. Ça fait très mal, donc on ne fait pas ça à la consultation. Malheureusement, on ne doit pas voir de nos jours cette forme clinique qu'on appelle l'ostéomyélite chronique.

(33:30 - 33:41)

C'est quoi l'ostéomyélite chronique? C'est l'évolution chronique d'une ostéomyélite aiguë, non-traitée ou maltraitée. C'est la même chose. Donc, c'est l'abcès supérieur non-traité.

(33:41 - 33:54)

Ça va évoluer vers l'ostéomyélite chronique. Dans ce cas, le pus qu'on a vu tout à l'heure, toujours quand il y a une connexion de pus, il va chercher un orifice. Un orifice pour sortir, pour entraîner.

(33:54 - 34:11)

Donc, il y aura des lésions pilaire, des fistules, des ulcérations de la peau, des persistance. Il y a des lésions musculaires, parce que ce sont des muscles qui n'ont pas travaillé pendant longtemps et qui ont été contaminés par le pus. Il y a l'améotrophie, la fibrose.

(34:13 - 34:30)

Il y a des lésions osseuses avec formation de séquestre osseux. C'est quoi le séquestre osseux? C'est la partie de l'os qui est morte, qu'on appelle séquestre osseux, que l'organisme va essayer de se débarrasser. Donc, ces séquestres osseux vont sortir par les fistules.

(34:33 - 34:46)

Donc, le traitement devient malheureusement difficile. Pourquoi difficile? Parce que l'aspect de l'os devient vermiforme libre. Donc, l'antibiotique ne va pas diffuser dans l'os très bien.

(34:47 - 35:10)

La partie de l'os morte, les séquestres osseux, aucun antibiotique ne va arriver à ces séquestres osseux parce que l'antibiotique arrive au niveau de l'os, au niveau des organes, par le sang. Si on a une partie de l'os morte à l'intérieur de l'os, l'antibiotique ne va jamais arriver à cette partie-là. Donc, ces malades évoluent par guérison, rechute, guérison, rechute.

(35:10 - 35:37)

Et guérison, rechute, il dit, rotentisme sur le cartilage de trois sens, des fractures pathologiques, donc des fistules cutanées. Donc, malheureusement, cette forme clinique, ça c'est l'exemple du même malade qu'on a vu, la psysupériosté, même traité, il a évolué. Parce que déjà, au stade de la psysupériosté, même avec le traitement correct, on n'a pas de garantie que le malade n'évolue pas vers la chronicité.

(35:38 - 35:47)

Vous voyez très bien ici des fistules cutanées. Il y a un morceau d'os qui sort par la fistule. Ce

morceau d'os, c'est de l'os mort qu'on appelle séquestre osseux.

(35:48 - 36:20)

Donc ici, ça va entraîner à coup sûr des complications, des complications avec l'os qui ne croîtra pas, comme l'os contralatéral, l'atteinte du cartilage de trois sens, le risque de fracture, parce que l'os devient très faible, d'accord, ce qu'on appelle fracture pathologique. Et le germe peut diffuser vers toute la diaphyse et peut toucher les épiphyses. Donc malheureusement, l'ostéomyélite chronique, c'est l'indice de développement sanitaire de chaque pays.

(36:21 - 36:37)

Quand on voit beaucoup d'ostéomyélite chronique, ça veut dire que le pays est très mal développé. Donc il y a un problème. Heureusement, ces dernières années, on ne voit pas beaucoup d'ostéomyélite chronique, mais il y a 15, 20 ans, l'ostéomyélite chronique était très, très fréquente.

(36:39 - 37:03)

Mais elle existe toujours. La première dose d'antibiotiques, on n'a pas le droit de demander un bilan et attendre avant de commencer le traitement. Chaque fois que vous avez un enfant qui a mal avec l'IF, ce n'est pas un traumatisme, même si la maman veut dire qu'il est en B, il a très mal.

(37:04 - 38:00)

Il faut prendre à la température une douleur osseuse plus fièvre égale à l'ostéomyélite. Jamais un traumatisme. n'entraîne une fièvre.

Ça, c'est toujours, il faut retenir ça. Mais si on ne prend pas la température, on ne va pas avoir ce qu'il y a de la fièvre ou pas. Donc il faut apprendre à prendre la température.

Et on donne ce conseil aux médecins dans les coins perdus. Le thermomètre ne coûte qu'au 20 dirhams. Si vous n'avez pas de thermomètre pour votre santé, il faut l'acheter.

Il ne faut pas dire que je n'ai pas pris la température parce qu'il n'y a pas de thermomètre à l'hôpital. Le thermomètre ne coûte qu'au 20 dirhams. Donc, les formes cliniques, on a parlé de l'ostéoimmunité aigüe, l'abcès supérieur, l'ostéoimmunité chronique.

(38:00 - 38:23)

Qu'il y a des formes cliniques qui sont rares, c'est l'atteinte du racisme. On a dit que l'ostéoimmunité aigüe hématogène peut toucher toutes les métaphyses, tous les os de l'organisme, mais par ordre de fréquence, il touche les métaphyses vertébrales. Mais on a des ostéoimmunités à l'os du pied, on peut avoir des ostéoimmunités à l'os de la main.

(38:24 - 38:44)

Là, j'ai mis cette forme particulière, c'est l'atteinte du racisme d'un vertèbre qu'on appelle la spondylodécide. La spondylodécide, c'est une ostéoimmunité aiguë, hématogène, toujours hématogène, qui atteint le disque et le vertèbre. C'est comme l'ostéoimmunité d'extrémité inférieure du genou, le début est brutal.

(38:45 - 39:11)

C'est un enfant qui a été jusqu'ici en bonne santé qui va présenter de façon brutale la douleur achidienne, la douleur de la vertèbre. C'est une douleur qui est intense, chronique, intense, pardon, aiguë, pas chronique, qui continue, insomnante. Parfois, ça entraîne une boiterie parce que le racisme, une douleur ou l'atteinte du racisme peut entraîner une boiterie.

(39:11 - 39:31)

La boiterie, je suis assez âgé, boiterie douloureuse parce qu'il a mal au niveau du racisme. C'est une génération d'installations brutales comme l'ostéoimmunité de la métaphyse fémurale inférieure, avec fièvre très élevée, frissons, altération de l'état général. Et ce qu'on va trouver, c'est le racisme vertébral.

(39:31 - 39:42)

Le racisme vertébral, c'est le racisme qui devient rectiligne. Il manque sa souplesse. Cette position d'orexitis, c'est une position ontalgique.

(39:42 - 40:03)

À la palpation, quand je palpe ce vertèbre atteint, ça peut être le troisième vertèbre lombaire, la douzième dorsale. Quand je palpe le racisme, à un certain moment, je commence la palpation, un, deux, trois, quatre, cinq. À un certain moment, quand j'arrive au vertèbre atteint, ça va entraîner une douleur très vive, intense.

(40:04 - 40:18)

À la palpation de l'épiphyse, malheureusement, le racisme vertébral est profond. Même la palpation de l'épineuse va entraîner la douleur. Ce n'est pas comme le fumeur, je peux palper directement la méthode.

(40:18 - 40:41)

Ici, même la palpation de l'épineuse entraîne une douleur provoquée avec une raideur rachidienne. J'ai mis ici, à travers l'orexitis vertébrale, le racisme devient linéaire. Généralement, le racisme n'est pas linéaire.

(40:41 - 40:51)

Il y a une courbure, une suppose dorsale. L'orthose lombaire devient la rectitude vertébrale, qui manque de souplesse. J'ai un exemple ici.

(40:52 - 41:13)

C'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui montre cette image ici de l'osculité vertébrale. La spondylodécite, est-ce que la spondylodécite peut entraîner une douleur très douloureuse? Oui. Est-ce qu'elle peut entraîner une poitrine non douloureuse? Non, c'est une poitrine douloureuse.

(41:17 - 41:34)

Je termine ici. Avant de faire l'IRM qui est sur l'image, ça veut dire que vous avez d'abord prescrit les antibiotiques au préalable? Les antibiotiques, j'attends pas. Je commence l'antibiotique.

(41:35 - 42:00)

Et supposons, supposons que j'ai commencé l'antibiotique. Supposons. Est-ce que ça va entraîner des effets indésirables, cette dose d'antibiotiques que j'ai donnée? Aux extrêmes, je donne l'antibiotique, je fais l'IRM, et je trouve, non, c'est pas un osteomyélite, je sais pas.

(42:00 - 42:19)

Il n'y avait pas de fièvre, il y avait la douleur sans fièvre, et j'avais peur, j'ai mis l'antibiotique, et j'ai récupéré le lendemain, il n'y avait pas de fièvre. Est-ce que le fait d'arrêter l'antibiotique, ça va entraîner des conséquences? Non. Donc il vaut mieux donner l'antibiotique.

(42:19 - 42:39)

Ce qui est grave, c'est de ne pas donner l'antibiotique pendant 24 heures, attendre le résultat de l'IRM, et après l'IRM, on vous dit que c'est l'osteomyélite atypique. J'ai attendu 24 heures, donc c'est sûr que j'aurai des complications. Toujours, je recommence l'antibiotique, j'attends pas.

(42:42 - 43:03)

Donc les formes topographiques. On a dit que l'osteomyélite touche le plus souvent la métaphyse fémorale, mais il faut savoir que l'osteomyélite peut toucher tous les os de l'organisme. Ça peut toucher les mûrices dans 10%, le radius dans 5%, le pelvis, le pied dans 13%.

(43:03 - 43:24)

Donc chaque fois qu'on a une douleur osseuse, une fièvre, c'est l'osteomyélite. Ça c'est une règle générale. Est-ce qu'on peut avoir une ostéomyélite sans fièvre? Là on entre dans les formes

atypiques.

(43:25 - 43:44)

Ça c'est l'exemple de quelqu'un qui a pris de l'antibiotique à l'aveugle à la maison. Pour cette ostéomyélite, une dose insuffisante, il vient à l'hôpital, on peut ne pas trouver la fièvre parce qu'il a pris de l'antibiotique par voie orale. La prise anarchique de l'antibiotique peut faire disparaître cette fièvre.

(43:52 - 44:15)

Après on va parler un peu des artrites symptomatiques. Au contraire de l'ostéomyélite, l'artrite c'est l'infection d'une articulation due à la diffusion d'un hémotogène dangereux ou d'une inoculation directe. Ici, au contraire de l'ostéomyélite, on a dit que la teinte de l'os se fait toujours par voie hémotogène.

(44:15 - 44:32)

Ici, en cas d'artrite, la localisation au niveau de l'articulation peut se faire par voie hémotogène. C'est le cas le plus fréquent, mais parfois par inoculation directe. Au contraire de l'ostéomyélite, l'ostéomyélite par inoculation directe.

(44:33 - 44:54)

C'est quoi l'inoculation directe? C'est quelqu'un qui est tombé sur une épine, une aiguille métallique, qui est entré dans l'articulation du genou. Donc, s'il entraîne une artrite, c'est une artrite par inoculation directe. Ici, il y a un franchement périlleux dans la cavité articulaire.

(44:54 - 45:13)

S'il y a une urgence médico-chirurgicale, le risque de destruction articulaire est très important. Vous savez très bien que l'articulation est faite pour bouger, pour permettre des mouvements. S'il y a une destruction d'une articulation, la première conséquence, c'est l'ankylose, c'est la perte d'articulation.

(45:14 - 45:36)

En plus d'autres complications. J'ai mis ce diapositif, on peut s'en sortir, c'est un peu très spécifique ici pour expliquer. En cas d'un nourrisson moins de deux ans par l'ostéomyélite tombée.

(45:36 - 45:48)

Je ne vais pas insister, on ne va pas vous demander ça. L'artrite septique de l'enfant. 80%, on a dit que les infections articulaires sont l'apparence de l'enfant.

(45:48 - 46:01)

Mais ici, dans mon cas d'artrite, 80% des cas sont des enfants moins de cinq ans. Ça, c'est très important. Les deux articulations les plus atteintes sont le genou et la hanche.

(46:02 - 46:15)

Mais toutes les articulations peuvent être touchées. Toujours cette règle-là. Quand je dis près du genou, loin du cou, ça ne veut pas dire que l'ostéomyélite ne peut pas toucher la clavicule, ne peut pas toucher le calcanium.

(46:16 - 46:58)

Ça peut le toucher, exceptionnellement. Mais en médecine, on commence par entraîner l'utale. Dans tout un articulaire, le début brutale, avec une douce articulaire d'apparition brutale, on est dans une articulation.

(46:58 - 47:09)

Ça entraîne rapidement une boîterie douloureuse. Boîterie douloureuse. Comment je peux dire une boîterie douloureuse? C'est l'adrien, parce qu'il a mal.

(47:10 - 47:28)

La boîterie non douloureuse. Le temps d'appui, c'est comme le temps d'appui du côté contrôlateur. C'est à l'aise, mais le temps d'appui au sol est le même par rapport au côté contrôlateur.

(47:28 - 47:43)

C'est la boîterie non douloureuse. En cas de boîterie douloureuse, le temps d'appui est très bref, parce qu'il a mal. Donc la boîterie douloureuse, qui peut entraîner même une impotence fonctionnelle totale.

(47:43 - 48:09)

La fièvre est très élevée, 39-40, souvent oscillante. Et à l'examen clinique, toute tentative de rémobilitation, même très douce, de cette articulation, est impossible, c'est très douloureux. Je vous donne l'exemple de la hanche.

(48:10 - 48:19)

Une boîterie douloureuse, puis une fièvre. J'ai demandé à l'enfant de marcher. Il m'a demandé l'examen clinique, la sémiologie clinique, l'inspection.

(48:20 - 48:31)

Ça va vous montrer quoi l'inspection ? Il marche, il chauffe, il boite. Chaque fois qu'il appuie. Maintenant la hanche droite.

(48:32 - 48:42)

Chaque fois qu'il appuie sur le membre inférieur droit. Et quand je l'examine en dékibitisme, je bouge l'articulation de cheville. Il n'a pas mal.

(48:42 - 48:51)

Je bouge l'articulation de genoux. Quand je fais bouger l'articulation de la hanche, ça entraîne une douleur vive. C'est impossible de continuer l'examen.

(48:56 - 49:01)

L'articulation superficielle. Maintenant, le genou. La hanche, c'est une articulation profonde.

(49:01 - 49:20)

Mais le genou, quand je fais bouger l'articulation, je trouve que le genou est imméfié. Le genou est imméfié. La sémiologie clinique, le choc rotilien.

(49:22 - 49:39)

Est-ce que vous connaissez ce choc rotilien ? Répondez oui ou non. Non. Le choc rotilien, c'est la sébiologie.

(49:42 - 49:54)

Oui, c'est celui de la patella. Avec le troclé FMO. Comment ? L'examen clinique.

(49:54 - 49:57)

Alors, le choc rotilien. La patella avec le troclé. L'examen clinique.

(49:58 - 50:12)

Oui, c'est ça le choc rotilien. Mais c'est quand on a un épanchement. Quand je bloque l'articulation du genou dehors en bas, chaque fois que je pousse sur la rotule, je la pousse vers le bas, vers le derrière.

(50:13 - 50:20)

C'est comme un piston. Quand je lâche, elle revient à sa place. Parce qu'il y a du liquide à

l'intérieur.

(50:20 - 50:27)

C'est le choc rotilien. Vous allez le faire, la sémiologie et l'examen en seul articulaire. Le choc rotilien.

(50:28 - 50:35)

Donc, on a deux genoux. On va trouver un choc rotilien. Ça veut dire qu'il y a du pus à l'intérieur.

(50:38 - 50:56)

C'est le choc rotilien. Ici, est-ce que la palpation de la métaphysique est douloureuse ou non douloureuse ? Douloureuse ou non douloureuse ? Si je prends l'article du genou. Non douloureuse.

(50:57 - 51:07)

Donc, dans le cas de l'article du genou, la palpation de la métaphysique est indoloreuse. Au contraire de l'ostéomyélite. Mais la mobilisation du genou est très douloureuse.

(51:07 - 51:18)

Avec la présence d'un choc rotilien. La ranche, c'est une articulation profonde. Je ne peux pas, à l'examen clinique, il n'y a pas de choc au niveau de la ranche.

(51:19 - 51:38)

Parce que c'est une articulation profonde. Donc, il faut palper les épiphyses et toutes les articulations accessibles. C'est une règle générale.

(51:39 - 51:49)

Si on a une artérie de la ranche, il faut faire attention. S'il y a une artérie associée de la cheville. Toujours en recherche, comme tout à l'heure, pour d'entrer toutes les ORL.

(51:50 - 52:07)

Pourquoi on met l'ORL ? Parce que c'est la porte d'entrée la plus fréquente. Devant la constatation d'un enfant fibrile, qui a de la fièvre, avec une boiterie douloureuse, le cycle d'arteries antibactériennes est très fortement suspecté. C'est une urgence thérapeutique.

(52:08 - 52:35)

Donc, artères fibriles égales artères septiques, jusqu'à preuve de contraire. Ici, j'ai mis la forme

clinique d'arteries du nouveau-né et du nourrisson. Là, j'ai la tranche d'âge.

(52:39 - 53:02)

Parce que souvent, ce sont des nourrissons qui sont hospitalisés pour un autre problème, dans un service de réanimation, ou un service de neonatologie, de piliagerie. Et qu'au cours de l'hospitalisation, qu'ils fassent cette arterie septique. Je m'explique, c'est l'exemple d'un nouveau-né.

(53:02 - 53:16)

Qui est hospitalisé pour une pneumopathie grave. Nous, on est concentré sur la pneumopathie. Mais au cours de l'hospitalisation, il va faire une arterie septique.

(53:16 - 53:49)

Souvent, au niveau de la hanche. Pour les infections sur-articulées, on a le staphylococccdoré, le germe le plus fréquemment responsable. Pourquoi ces enfants-là, hospitalisés pour, je ne sais pas, une myningite grave, une pneumopathie grave, fassent une arterie septique au cours de leur hospitalisation ? Parce que ce n'est pas le même germe qui entraîne la myningite ou la pneumopathie qui va entraîner l'arterie septique.

(53:49 - 53:57)

Ça, c'est très important. Ils font une arterie au staphylococccdoré. Pourquoi ils le fassent ? Parce que généralement, ce sont des enfants immunodéprimés.

(53:58 - 54:24)

Et qui va contaminer ces enfants ? Les étudiants en médecine, le personnel, si on ne se lave pas les mains très bien, le service de réanimation, la neonate, parce que le germe, il est dans la peau. Ce sont des enfants qui sont victimes de la mauvaise hygiène. Le personnel soignant, généralement les étudiants, les plaignants, les personnels infirmiers.

(54:24 - 54:42)

Donc, on touche ces enfants, on ne se lave pas les mains très bien avec le gel hydroalcoolique. Et on va contaminer ces enfants et ils fassent une arterie septique. Le problème de ces arteries, ce sont des enfants qui sont hospitalisés pour un autre problème.

(54:42 - 54:48)

Et on est concentré sur ce problème. Maintenant, je prends le cas de Meningite. C'est la Meningite.

(54:49 - 55:02)

C'est un enfant hospitalisé pour une Meningite. Quand il fasse une arterie septique, nous, on ne va pas se rendre compte rapidement. Parce que chaque jour, nous, on se concentre sur la Meningite.

(55:02 - 55:13)

Est-ce qu'il va se réveiller ou pas, l'évolution ? Et lui, il a fait une arterie. Malheureusement, le tableau clinique n'est pas parlant. La symbiologie clinique, il est pauvre.

(55:14 - 55:22)

Je dis que la boîterie ne marche pas, c'est un peu difficile. Il ne peut pas marcher pour voir la boîterie. La fièvre est déjà sous antibiotiques.

(55:23 - 55:33)

Donc, il n'a pas de fièvre. Donc, cliniquement, quatre ou cinq cliniques doivent attirer l'attention. Deux médecins cliniques, l'arthrite du nouveau-né nourissant.

(55:34 - 55:57)

Soit une limitation douloureuse de la mobilisation articulaire. C'est la maman qui veut changer les couches de son enfant, parce que les mamans ont le droit d'entrer une fois par jour visiter leur enfant. Il a constaté que chaque fois qu'il veut changer la couche, la hanche droite, par exemple, l'enfant commence à pleurer.

(56:02 - 56:22)

Il a constaté qu'un membre est devenu pseudo-paralytique. Parce que l'enfant, la position spontanée, c'est la flexion des deux hanches. Il a constaté qu'un membre est devenu pseudo-paralytique.

(56:22 - 56:39)

Ou une position anormale permanente d'un membre. Le membre dit « ima » en extension, l'autre en flexion. Tous ces cliniques doivent attirer l'attention des personnes soignantes et faire, pour confirmer le diagnostic, la fièvre.

(56:52 - 57:26)

Malheureusement, ces enfants-là, on les voit avec un retard, presque toujours. Vous avez des questions pour l'arthrite nouveau-né nourissant ? Comment peut-on avoir la présence d'un enfant des articulations profondes ? C'est l'échographie. Je trouve la mobilisation de la hanche

douloureuse avec la fièvre en cas d'arthrite cyptique grand-enfant.

(57:27 - 58:02)

Je demande l'échographie qui va montrer la présence depuis les visibles sur le plan échographique. Une autre forme clinique est l'atteinte de l'articulation sacroiliaque. L'articulation sacroiliaque et l'articulation postérieure.

(58:03 - 58:24)

Ici, j'ai mis l'articulation sacroiliaque qui peut être touchée, mais je la sorte, c'est un peu spécifique. Il faut se souvenir que l'arthrite cyptique touche surtout le genou et la hanche, mais il peut toucher l'épaule, le coude, le poignet, mais dans 70% des cas, c'est la hanche et le genou. C'est très important.

(58:28 - 58:44)

Ici, en clinique, chaque fois qu'on a une douleur de l'articulation, l'équivalent de la douleur, il y a la boiterie douloureuse. Quand on fait l'appui sur le ventre, c'est un appui, bref, parce qu'il a mal. Il y a la boiterie douloureuse.

(58:44 - 59:20)

À l'examen clinique, je trouve la fièvre, la mobilisation de l'articulation concernée qui est très douloureuse avec la fièvre et l'arthrite cyptique, jusqu'à preuve de contraire. Je n'ai pas voulu mettre les arthritides inflammatoires, le rhumatisme qui peut donner parfois un épongeur plus infubriqué. Il faut juste apprendre la retenue chaque fois qu'il y a une boiterie avec la fièvre sur l'arthrite cyptique.

(59:21 - 59:52)

Vous avez des questions ? Le nouveau-né, le nourissant, on l'a mis sur le plan clinique parce que c'est un tableau clinique qui est atypique. Généralement, ce sont des enfants qui sont hospitalisés pour un autre problème qu'ils passent l'arthrite au cours de l'hospitalisation. C'est une arthritide causée par des mauvais gestes d'hygiène.

(59:52 - 1:00:58)

C'est pourquoi on insiste quand vous allez faire le passage par réanimation qu'il faut se laver les mains très fréquemment. Chaque fois qu'on veut rentrer au service, on lève une blouse, on met un casque, on se lave les mains. On veut examiner le nouveau-né, on se lave les mains parce que pour notre peau, il est plein de staphylococcus aureus.

Ce sont des enfants qui sont immunodéprimés. Donc, on risque d'inoculer ce gène et entraîner l'arthrite. Donc, on ne va pas parler de toutes les infections et du patient.

(1:01:00 - 1:01:37)

On ne va parler que des infections les plus fréquentes que vous allez rencontrer dans votre pratique comme généraliste ou comme médecin spécialiste. On va parler des panaries les plus fréquentes des gènes, de l'ézépale, et de la séchon. Quelle est la définition d'une panarie ? La panarie, c'est une infection aiguë des parties molles de la pulpe du doigt.

(1:01:38 - 1:01:48)

La pulpe de l'orteil, c'est une panarie. Généralement, c'est la pulpe du doigt. Est-ce que la panarie peut toucher un orteil ? Oui.

(1:01:51 - 1:02:05)

Mais souvent, on parle du doigt. Le gène responsable, c'est le staphylocoque doré dans 70 %. Le diaglossique, il est clinique. La panarie est l'apanage de tous les âges.

(1:02:06 - 1:02:20)

Ce n'est pas comme les infections articulaires de l'enfant. Ici, ça peut toucher 40 ans, 50 ans, 6 ans, 7 ans, tous les âges. Généralement, il y a une porte d'entrée.

(1:02:25 - 1:02:40)

Ce panarie va évoluer en stade. D'abord, le stade d'inoculation. C'est la phase où le gène est entré dans les parties molles de la partie distale du doigt, la pulpe du doigt.

(1:02:42 - 1:02:59)

Ce stade d'inoculation, il est souvent méconnu. C'est une douleur qui est rapidement calmée. C'est le patient qui a présenté cette douleur atypique qui a disparu par la suite.

(1:02:59 - 1:03:11)

Ce stade d'inoculation, généralement, il est inconnu. À ce stade d'inoculation, à l'examen clinique, il n'y a rien. Dans le stade où le gène est entré.

(1:03:12 - 1:03:31)

Le stade d'inoculation, c'est le stade fligmasique. Le stade fligmasique, il y a une douleur qui est localisée au niveau de la pulpe du doigt, qui est modérée. C'est une douleur qui est absente la nuit.

(1:03:32 - 1:03:42)

Le patient a mal, mais il arrive à dormir le soir. La fièvre, parfois on a de la fièvre, parfois on n'a pas de la fièvre. La fièvre est inconstante.

(1:03:44 - 1:04:10)

Mais ici, c'est l'intérêt de l'examen clinique. À l'examen clinique, à l'inspection, on note que la peau est inguiale, inguiale, inguiale, inguiale, l'ongle. La peau autour de l'ongle, sur la pulpe du doigt, est rouge et légèrement massive.

(1:04:11 - 1:04:36)

Et quand je la touche, cette peau est chaude. Dans l'interrogatoire, on trouve une peau d'entrée. Peau d'entrée, ça peut être une piqûre d'insectes, à la place d'une moustique, une mosquito bite.

(1:04:37 - 1:05:11)

Ça peut être une petite plaie non traitée. Ça peut être, je ne sais pas, unicomycose, surinfectée, d'accord. On peut trouver un facteur favorisant, comme le diabète.

Quelqu'un qui est diabétique, donc il est prédisposé à faire le panache. C'est le stade phlegmatique. Si je ne traite pas mes douillages vers le stade d'ADA, il va évoluer vers le deuxième stade, d'abord le stade phlegmatique.

(1:05:12 - 1:05:25)

Vous voyez que la peau, l'ongle est là, la peau est inguiale, elle est rouge, chaude. Chaude, c'est à la palpation. La palpation, elle est chaude, mais il n'y a pas de liquide à l'intérieur.

(1:05:26 - 1:05:34)

Parce que le liquide, on peut le sentir. Donc à la palpation, ici, il est chaud. C'est le stade phlegmatique.

(1:05:36 - 1:05:50)

Le stade de collection, c'est très important. Le stade de collection, la douleur qu'on a flouée dans le stade phlegmatique, elle était présente, mais elle se calme la nuit. Le patient dort la nuit calmement, il n'y a pas de problème.

(1:05:51 - 1:06:05)

La douleur est intense, pulsative et insomnuante, il n'arrive pas à dormir. Là, il n'y a pas de douleur, il y a de la pression à l'intérieur. Il y a de la pression dans les parties molles.

(1:06:06 - 1:06:28)

La douleur est intense, pulsative et insomnuante. La fièvre est constante. Le stade phlegmatique, on l'a dit, ça peut avoir une fièvre à 38, mais le patient peut être apéritif.

(1:06:28 - 1:06:46)

Mais ici, la fièvre est présente, constante. L'examen clinique, à l'inspection, la peau est rouge. Mais à la palpation, elle est chaude, tendue, les perles se ramollent dans son centre.

(1:06:46 - 1:06:54)

Le centre de la collection se ramollit. Il y a un liquide à l'intérieur. On sent qu'il y a du liquide.

(1:06:54 - 1:07:03)

On sent qu'il y a du liquide à l'intérieur. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, du liquide. Il pue à l'intérieur.

(1:07:10 - 1:07:21)

Pour la douleur pulsative, la douleur pulsative est intense, pulsative. C'est très intense. Mais elle est toujours là.

(1:07:26 - 1:07:35)

Voici un exemple. La peau est rouge, tuée. Mais on voit qu'elle se ramollit.

(1:07:36 - 1:07:44)

Il y a une sorte de liquide. Quand je parle d'ici, on sent qu'il y a du liquide à l'intérieur. Je sens qu'il y a du liquide à l'intérieur.

(1:07:45 - 1:08:01)

Il y a le pus. Le maquis est en stade phlegmatique. Parfois même, le pus s'enlève, il y a un orifice et c'est fistulisé dès que la collection, on crache le pus.

(1:08:16 - 1:08:44)

Toujours en cas d'infection des parties mortes, les doigts, la main, c'est une réaction du système lymphatique, ce qu'on appelle la lymphangite. La lymphangite, c'est le système de drainage lymphatique, elle répond à l'infection, ce qu'on appelle la lymphangite. C'est le territoire de drainage lymphatique de la région atteinte par l'infection qui est visible par des traînées secrétées inflammatoires et douloureuses.

(1:08:45 - 1:09:01)

Traînées de lymphangite, c'est l'infection du système lymphatique. Le système lymphatique assure la pompe à des traînées rougeâtres comme ça, c'est ce qu'on appelle la lymphangite. Qu'il y ait des chiffres de panaris, qu'il y ait de l'inflammation, qu'il y ait des cas d'infection des parties mortes.

(1:09:02 - 1:09:31)

Mais c'est inconstant, parfois on trouve cette lymphangite, parfois on ne la trouve pas, ça dépend de la réponse immunitaire du patient. Donc là j'ai mis seulement le traitement et ça change rapidement. Il y a un nouveau stade phlegmatique, des bains antiseptiques, antivirus, mais au stade de collection, c'est où il y a le traitement chirurgical avec les séquelles.

(1:09:32 - 1:10:43)

C'est pourquoi il faut faire le diagnostic avec, pas avec le retard, d'accord ? Le phlegmat de l'hygiène palmaire, c'est quoi le phlegmat de l'hygiène palmaire ? Le phlegmat de l'hygiène palmaire, c'est une infection des gaines fléchisseurs. Les tendons fléchisseurs créés sur la chaire de l'anatomie, ils sont enveloppés de gaines, des gaines synoviales. La gaine, c'est le deuxième, arrive ici, c'est le quatrième, troisième et deuxième arrivent jusqu'à la pleine palmaire distale et la gaine digitale, le pouce, arrive jusqu'au poignet.

(1:10:43 - 1:11:10)

Donc l'infection de ces gaines fléchisseurs, il y a la thénosynovite, des gaines fléchisseurs qu'on appelle. Et vous allez voir très bien que la disposition anatomique de ces gaines aura une conséquence sur la simiologie. Si je prends l'infection de la gaine fléchisseur du pouce, donc ça va toucher toute la gaine jusqu'aux poignets.

(1:11:11 - 1:11:50)

Si je prends la gaine fléchisseur deuxième, troisième, quatrième, ça touche la gaine jusqu'au pli palmaire du stade, donc avec la rougeur des symptômes, ils vont arriver jusqu'au pli palmaire du stade. Donc, s'il y a l'atteinte de la gaine digitale du troisième, donc les symptômes cliniques arrivent jusqu'à cette région là. Mais s'il y a l'atteinte de la gaine fléchisseur du cinquième doigt, donc la tumefaction va arriver jusqu'aux poignets.

(1:11:50 - 1:12:07)

Ce sont des conséquences anatomiques. Donc, au cas d'infection d'une gaine fléchisseur, l'essai fonctionnel, c'est la douleur qui pulsatille le long de la gaine. Si je prends le pouce, donc la douleur va arriver jusqu'aux poignets.

(1:12:08 - 1:12:26)

Si j'arrive le deuxième doigt, la douleur arrive jusqu'au pli palmaire du stade parce que la gaine, c'est-à-dire le pouce, arrive jusqu'aux poignets. Est-ce que vous avez compris ça ? Donc la gaine, c'est-à-dire le pouce, arrive jusqu'aux poignets. La gaine cinquième arrive jusqu'aux poignets, mais deuxième, troisième, quatrième, il arrive jusqu'au pli palmaire du stade.

(1:12:32 - 1:12:57)

Donc, ces ténocinovites, ils évoluent en trois stades. La ténocinovite inflammatoire, c'est le début, à l'entraînement du gène, la ténocinovite courante et la ténocinovite nécrosante grave. Pour la ténocinovite inflammatoire, c'est le stade de début, il n'y a pas de fièvre, c'est une douleur à la palpation du cul de sac et à la mobilisation, la palpation de la gaine.

(1:13:03 - 1:13:29)

En cas de ténocinovite périnente, la douleur est intense, permanente et insomnante avec attitude des doigts encrochés et réductibles. Si vous voyez les doigts encrochés qu'on peut voir ici, donc les doigts encrochés. Quand je fais l'extension et je le lâche, il devient encroché et il se rétracte.

(1:13:29 - 1:14:10)

Vous voyez la peau qui est rouge, la ténocinovite du troisième, donc tout le trajet qui est la douleur, l'insomnante, la fièvre avec ici, l'inflammatoire rouge, c'est le trajet de la gaine Kemmel, donc la gaine qui arrive ici, avec l'aspect encroché. Donc ça se contracte spontanément, encroché, l'aspect encroché. En cas de ténocinovite nécrosante, la peau devient noirâtre et cet aspect encroché disparaît.

(1:14:11 - 1:14:34)

Elle disparaît parce que le tendon est parti, le tendon s'échisseur, donc on n'a plus de tendons, ça c'est très grave. Il y a la ténocinovite nécrosante, il y a de la nécrose, vous voyez la peau qui est noire et quand je fais l'extension sur le doigt, elle reste en extension parce qu'elle n'a plus de tendons. Le tendon est rompu, c'est ça la gravité de la ténocinovite.

(1:14:35 - 1:15:08)

Donc il y a trois stades, ténocinovite inflammatoire, ténocinovite pérulante, douleur intense, permanente, aspect inflammatoire de la peau, aspect encroché et réductible. Pour la ténocinovite nécrosante, il n'y a plus de crochet parce que la peau, le crochet est réductible et quand je veux faire l'extension de ce doigt atteint, impossible. Parce qu'il est en crochet réductible, ici le crochet devient réductible parce que le tendon est parti.

(1:15:08 - 1:15:47)

C'est ça la gravité de la ténocinovite où il y a le risque de rupture du tendon. Le traitement est

toujours chirurgical parce que cette gaine, il faut bien laver, il faut l'ouvrir et en cas de rupture, ça devient très compliqué parce qu'il n'a plus de tendons, douleur intense, plusieurs interventions chirurgicales avec des risques. Donc la ténocinovite, c'est une pathologie grave, toujours il y a un port d'entrée.

(1:15:47 - 1:16:06)

Je répète, si il y a un port d'entrée, ça peut être épuquer, ça peut être un panarin non traité. Un panarin, si on ne le traite pas, il peut évoluer vers une ténocinovite. Rapidement, je parle dans le segment du bruit, oui, oui, oui.

(1:16:07 - 1:16:24)

Je n'ai pas compris l'intérêt de chercher le port d'entrée. L'intérêt, c'est de traiter les ports d'entrée, c'est ça. Quand je cherche un port d'entrée, une plaie, l'intérêt, c'est de traiter ces ports d'entrée, c'est de prévenir la population.

(1:16:24 - 1:16:34)

S'il y a une plaie, il faut la bien traiter. Et un autre intérêt, c'est de faire le prélèvement. La port d'entrée, je peux faire un prélèvement bactériologique pour trouver le gène.

(1:16:35 - 1:16:51)

Je sais que le staphylococque, dans 70% des cas, mais parfois il y a d'autres gènes. Donc la port d'entrée, on fait le prélèvement et on sensibilise les sujets diabétiques parce que c'est pas l'orthologie panarie. La thénocynovite, ça touche surtout les diabétiques.

(1:16:51 - 1:17:03)

Le panarie peut toucher toute la population, mais la thénocynovite, c'est surtout les sujets diabétiques qui le dépriment. Donc la port d'entrée, il faut la traiter. Si je traite un panarie correctement, il ne va pas faire une thénocynovite.

(1:17:03 - 1:17:26)

D'accord ? Un panarie peut être un port d'entrée pour la thénocynovite. Les espaces cellulaires, ça c'est l'abcès. L'irispelle, est-ce que vous connaissez l'irispelle ? C'est une dermo-hypocytérien aiguë, non-écroissante.

(1:17:28 - 1:17:44)

Donc non-écroissante, je répète, c'est pas une écroissante. Liée le plus souvent ici à un streptococque bêta-hémolytique. Toutes les infections qu'on a vues depuis le début de cette révision, elles sont dues au staphylococque doré, dans la plupart du temps.

(1:17:45 - 1:17:54)

Mais ici, c'est un streptococque bêta-hémolytique. L'irispelle, si je mets le staphylococque doré, non. C'est le streptococque bêta-hémolytique.

(1:17:55 - 1:18:02)

Il est surtout l'adulte. Il atteint la jambe dans 95% des cas. Il faut retenir ça.

(1:18:06 - 1:18:29)

Lysine fonctionnelle, grosse jambe avec douleur, fièvre et frissons. Et l'examen clinique, il y a, qu'est-ce qu'on trouve ? À l'inspection, il y a la rougeur, l'œdème, parfois quelques bulles. À la palpation, il y a un placard inflammatoire, quand je palpe la jambe.

(1:18:30 - 1:18:46)

Un placard inflammatoire qui est chaud, douloureux. Son bourrelet périphérique, il y a un lien entre ce bourrelet et la peau normale. Qui sont les signes négatifs ? Il n'y a pas de nécrose, mais qui est une chose noire, il n'y a pas de nécrose.

(1:18:46 - 1:19:02)

Il n'y a pas de trouble de sensibilité. Toujours, il faut chercher la porte d'entrée en cas de risipelle de la jambe, intertrigo, c'est l'infection entre les orteils. Ça peut être une plaie, un nul cercle.

(1:19:05 - 1:19:22)

Et bien sûr, il n'y a pas de signe de maladie thrombotique, parce que la maladie a la thrombose. La flibide peut donner un gros mollet, mais en cas de flibide, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de frissons. Il y a un signe de romance positive, vous allez voir après, on ne va pas entrer dans les détails.

(1:19:23 - 1:19:35)

Donc, ici, vous voyez très bien l'inspection. Il y a un placard rouge, à la palpation, c'est un placard qui est rouge, inflammatoire, sauronne rouge. On sent qu'il est chaud par rapport à la peau normale.

(1:19:36 - 1:19:50)

Sans bourril périphérique, il n'y a pas de limite palpable entre la peau normale et la peau rouge. Et entre les doigts, on va trouver un intertrigo, une porte d'entrée. Ici, la même chose, on peut trouver des bulles.

(1:19:52 - 1:20:12)

Les bulles, vous voyez le placard inflammatoire rouge, sans bourril périphérique avec la peau normale, avec fièvre. La jambe, c'est 95% des cas. Parfois, le visage peut être touché dans 5% des cas seulement.

(1:20:12 - 1:20:40)

Vous voyez ici, placard inflammatoire, et la porte d'entrée, il y avait une plaie ici, d'accord? Le traitement, ici, c'est le tocoque, et le diagnostic différentiel, c'est quoi? C'est la faciète nécrosante. Dans ce cas, la douleur, elle est très intense. Il y a une altération de l'état général et surtout à l'examen clinique, il y a de la nécrose.

(1:20:40 - 1:20:53)

En cas d'irisipelle, il n'y a pas de nécrose. Il y a de la nécrose, et ici, c'est le diagnostic, le traitement et les chirurgicales. C'est grave, cette pathologie, la faciète nécrosante.

(1:21:03 - 1:21:20)

Et le dernier, je donne à l'abcès chaud parce qu'il y a l'abcès froid. L'abcès froid ou à la tuberculose d'un seul. La tuberculose, qu'on appelle abcès froid, parce qu'il peut durer des mois et qu'il peut donner un abcès qu'on appelle abcès froid.

(1:21:20 - 1:21:48)

L'abcès chaud, c'est toute une connexion purulente, localisée, développée dans un lieu formé avec les signes cardinaux de l'inflammation qui sont la tumeur, il y a la tumefaction, la rougeur, la chaleur et la douleur. Dans l'abcès chaud, donc l'abcès chaud, c'est qu'on a des infections microbiennes, le staphylococque dans la plupart des cas. L'abcès froid, c'est la tuberculose, on ne va pas l'utiliser.

(1:21:51 - 1:22:16)

Donc, il reste 7 minutes, on va faire quelques QCM pour ne pas... Alors, première QCM. Dans l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité inférieure de fumeur, le début de la symptomatologie est brutal, progressif. La porte d'entrée peut être envoyée au RER.

(1:22:16 - 1:23:04)

À l'inspection, elle est présente d'une tumefaction d'extrémité inférieure à la palpation de douleurs métaphysales intenses et circulaires, améliorations de genoux et douloureuses. Alors, est-ce que vous avez répondu? La porte d'entrée peut être envoyée au RER. Donc, très bien, à la porte d'entrée, à l'inspection, il n'y a pas de tumefaction.

(1:23:04 - 1:23:14)

Quand je dis extrémité aiguë, l'ostéomyélite aiguë, il n'y a pas de tumefaction. Dans l'abcès chaud, le début de la symptomatologie est brutal. La fièvre au début est très élevée avec intégration vitale générale.

(1:23:15 - 1:23:30)

Au stade de diffusion, la tumefaction dure au centre, en pâte à la périphérie, rouge, chaude, douloureuse à la pression. Au stade de collection, la tumefaction en pâte à la périphérie ramollie au centre. La présence d'une collection liquidienne.

(1:23:30 - 1:26:02)

Alors, le deuxième QCM, alors, le deuxième QCM. C, D, E, très bien. C, D, E, très bien.

(1:26:08 - 1:27:27)

6, on termine par 6. 5, en cadavre de supériorité d'extrémité inférieure de fumeur, oui. Alors, donc là, il faut faire attention. Le début de la symptomatologie brutale, non.

(1:27:28 - 1:27:36)

La supériorité, non. C'est déjà un malade qui a fait l'ostéomyélite. Les signes généraux sont sévères, non.

(1:27:37 - 1:27:50)

On a dit en cadavre de supériorité, il n'y a plus d'hyperpression, donc. L'inspection présente une tumefaction, oui. À la palpation, douleur métaphysaire intense, non.

(1:27:50 - 1:27:57)

Parce qu'il n'y a plus cette hyperpression. Là, on est au stade de la psy supériorité. Il y a la tumefaction, surtout la tumefaction.

(1:27:57 - 1:28:07)

On regarde la métaphyse avec une petite douleur, pas la douleur métaphysaire intense circulaire. Parce que là, c'est qu'il n'y a plus d'hyperpression dans l'os. Il faut bien expliquer à la physiopathe, d'accord.

(1:28:08 - 1:28:28)

Donc, c'est là, je parle de la psy supériorité, je ne parle pas de l'ostéomyélite. En cas de la psy supériorité, le début de la symptôme n'est pas brutal. Donc, c'est un malade qui a déjà fait

l'ostéomyélite, il vit, donc, avec, on est entré dans la chronicité.

(1:28:28 - 1:28:47)

Les signes généraux sont sévères, non. Je pense que le temps, on a fini, on a fini. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en envoyer, j'écris mon email.

(1:29:07 - 1:29:17)

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris les choses, vous pouvez me les envoyer sur un email, d'accord. Je vous remercie.